

Пероральные фторпиримидины в третьей линии химиотерапии у больных диссеминированным раком молочной железы

Омарова И.М., Абдрахманова А.Ж., Шерстов С.Ю.

Карагандинский областной онкологический диспансер

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Ежегодно в мире рак молочной железы выявляется более чем у 1 млн. человек, занимая первое место в структуре заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований у женщин [1]. Среди выявленных случаев заболевания более 50% составляют диссеминированные формы рака молочной железы. Медиана продолжительности жизни больных диссеминированным раком молочной железы обычно не превышает 18–24 месяца, и только 15 % больных этой группы переживают 5 летний рубеж [2–4]. Методом выбора у данной категории больных остается системная химиотерапия. Из-за применения на более ранних стадиях заболевания высокоактивных препаратов (антрациклинов, таксанов) растет число больных, устойчивых к стандартной химиотерапии.

Цель исследования

– изучение сравнительной эффективности капецитабина и тегафура в III третьей линии химиотерапии у больных диссеминированным раком молочной железы.

Материал и методы исследования

В рамках открытого нерандомизированного исследования в отделении химиотерапии Карагандинского областного онкологического центра обследование и лечение проведено 39 пациенткам с диссеминированным морфологически подтвержденным раком молочной железы, в возрасте от 37 до 74 лет, ранее получавшим химиотерапию II линии (антрациклины, таксаны), с ожидаемой продолжительностью жизни более 3 месяцев.

Лечение капецитабином проведено 21 больным, использован стандартный дозовый режим по 1250 мг/м² - 2 раза в день *per os* в течение 14 дней с перерывом между курсами 7 дней. Всего проведено 89 курсов, в среднем 4,2 курсов, минимально – 2, максимально – 6.

Лечение тегафуром проведено 18 больным, использован стандартный дозовый режим по 1000 мг/м² - 2 раза в день *per os* в течение 15 дней с перерывом между курсами 21 день. Всего проведено 68 курсов, в среднем 3,8 курсов, минимально – 2, максимально – 6.

В исследовании применялись препараты: капецитабин торговое название «Кселода» производства компании «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд»; тегафур торговое название «Фторафур» производства компании «Гриндекс».

Результаты и обсуждение

Оценка эффективности проводилась после завершения 4 и 6 курсов лечения по критериям ВОЗ. Результаты лечения представлены в таблице 1.

При сравнении показателей эффективности лечения статистически достоверной разницы между группами не получено.

Несмотря на то, что процент общего эффекта в группах составил всего 19,0% и 16,7% и был ниже, чем соответствующие литературные данные (20 - 26%) [5,6,7] следует отметить,

ПЕРОРАЛЬНЫЕ ФТОРПИРИМИДИНЫ В ТРЕТЬЕЙ ЛИНИИ ХИМИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ДИССЕМНИРОВАННЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Омарова И.М., Абдрахманова А.Ж., Шерстов С.Ю.

Карагандинский областной онкологический диспансер

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Ежегодно в мире рак молочной железы выявляется более чем у 1 млн. человек, занимая первое место в структуре заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований у женщин [1]. Среди выявленных случаев заболевания более 50% составляют диссеминированные формы рака молочной железы. Медиана продолжительности жизни больных диссеминированным раком молочной железы обычно не превышает 18–24 месяца, и только 15 % больных этой группы переживают 5 летний рубеж [2–4]. Методом выбора у данной категории больных остается системная химиотерапия. Из-за применения на более ранних стадиях заболевания высокоактивных препаратов (антрациклинов, таксанов) растет число больных, устойчивых к стандартной химиотерапии.

Цель исследования – изучение сравнительной эффективности капецитабина и тегафура в III третьей линии химиотерапии у больных диссеминированным раком молочной железы.

Материал и методы исследования. В рамках открытого нерандомизированного исследования в отделении химиотерапии Карагандинского областного онкологического центра обследование и лечение проведено 39 пациенткам с диссеминированным морфологически подтвержденным раком молочной железы, в возрасте от 37 до 74 лет, ранее получавшим химиотерапию II линии (антрациклины, таксаны), с ожидаемой продолжительностью жизни более 3 месяцев.

Лечение капецитабином проведено 21 больным, использован стандартный дозовый режим по 1250 мг/м² - 2 раза в день *per os* в течение 14 дней с перерывом между курсами 7 дней. Всего проведено 89 курсов, в среднем 4,2 курсов, минимально – 2, максимально – 6.

Лечение тегафуром проведено 18 больным, использован стандартный дозовый режим по 1000 мг/м² - 2 раза в день *per os* в течение 15 дней с перерывом между курсами 21 день. Всего проведено 68 курсов, в среднем 3,8 курсов, минимально – 2, максимально – 6.

В исследовании применялись препараты: капецитабин торговое название «Кселода» производства компании «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд»; тегафур торговое название «Фторафур» производства компании «Гриндекс».

Результаты и обсуждение. В группе кселоды частота общего эффекта составила 19,0±8,8% в группе фторафура

Таблица 1. Эффективность фторпиримидинов в III линии химиотерапии диссеминированного рака молочной железы

Эффективность	Кселода n=21		Фторафур* n=18	
	абс.	%	абс.	%
Полный регресс	0	0	0	0
Частичный регресс	4	19,0±8,8%	3	16,7±9,0%
Стабилизация	9	42,9±11,1%	7	38,9±11,8%
Прогрессирование	8	38,1±10,9%	8	44,4±12,1%
Общий эффект	4	19,0±8,8%	3	16,7±9,0%
Уровень контроля заболевания	13	61,9±10,9%	10	55,6±12,1%

Примечание – достоверность $P \geq 0,05$; разница между группами не достоверна

Таблица 2. Гематологическая токсичность фторпиримидинов в III линии химиотерапии диссеминированного рака молочной железы

Показатели	Кселода n=21		Фторафур* n=18	
	абс.	%	абс.	%
Нейтропения I - II степени	9	42,8±12,1	7	38,9±11,8
III - IV степени	6	28,6±10,1	2	11,1±7,6
Тромбоцитопения I - II степени	3	14,2±7,8	5	26,8±10,7
III - IV степени	1	4,8±4,6	1	5,6±5,4
Анемия I - II степени	1	4,8±4,6	1	5,6±5,4
III - IV степени	-	-	-	-
Общее количество осложнений	9	42,8±12,1	7	38,9±11,8

Примечание – достоверность $P \geq 0,05$; разница между группами не достоверна

Таблица 3. Негематологическая токсичность фторпиримидинов в III линии химиотерапии диссеминированного рака молочной железы

Показатели	Кселода n=21		Фторафур* n=18	
	абс.	%	абс.	%
Тошнота, рвота I - II степени	7	30,0±10,2	12	66,7±11,4*
III - IV степени	6	28,6±10,1	10	55,6±12,1
Мукозиты I - II степени	1	4,8±4,6	2	11,1±7,6
III - IV степени	1	4,8±4,6	1	5,6±5,4
Ладонно-подошвенный синдром I - II степени	-	-	-	-
III - IV степени	11	52,3±11,2	-	-
Общее количество осложнений	11	52,3±11,2	12	66,7±11,4

Примечание – * достоверность $P \leq 0,05$

что общий эффект был довольно высоким учитывая, что химиотерапия проводилась в монорежиме и в исследование включены пациенты с диссеминированным раком молочной железы, ранее получившие массивную химиотерапию I и II линии.

Результаты изучения гематологической токсичности представлены в таблице №2.

Изучение токсичности показало, что статистически значимых различий в частоте и тяжести гематологических побочных эффектов между группами лечения не отмечается.

Результаты изучения негематологической токсичности представлены в таблице 3.

Изучение частоты негематологической токсичности не выявило достоверной разницы между группами.

Изучение профиля гематологической токсичности показало, что в группе кселоды в она основном была представлена

соответственно 16,7±9,0%.

При сравнении показателей эффективности лечения статистически достоверной разницы между группами не получено.

Изучение профиля гематологической токсичности показало, что в группе кселоды в она основном была представлена ладонно-подошвенным синдромом у 52,3 % больных, тогда как в группе фторафура наблюдалась гастроинтестинальная токсичность, тошнота и рвота зарегистрирована у 66,7% больных.

Закключение. Данные полученные в этом исследовании указывают, что кселода и фторафур в III линии химиотерапии обладает сопоставимой эффективностью у больных диссеминированным раком молочной железы с массивным предшествующими лечением. Гематологическая токсичность в целом была слабой, при этом 3 и 4 степень возникала нечасто. При приеме кселоды основной токсичностью являлась негематологическая токсичность, главным образом ладонно-подошвенный синдром, степень выраженности которого варьировала. Основным проявлением негематологической токсичностью фторафура являлись тошнота и рвота.

Ни один из представленных режимов химиотерапии не продемонстрировал преимуществ в эффективности и переносимости.

ладонно-подошвенным синдромом у 52,3 % больных, тогда как в группе фторафура наблюдалась гастроинтестинальная токсичность, тошнота и рвота зарегистрирована у 66,7% больных.

Закключение

Данные полученные в этом исследовании указывают, что кселода и фторафур в III линии химиотерапии обладает сопоставимой эффективностью у больных диссеминированным раком молочной железы с массивным предшествующими лечением – объективный эффект у 19,0 % и 16,7 % больных соответственно.

Гематологическая токсичность в целом была слабой, при этом 3 и 4 степень возникала нечасто. При приеме кселоды основной токсичностью являлась негематологическая токсичность, главным образом ладонно-подошвенный синдром, степень выраженности которого варьировала. Основным проявлением негематологической токсичностью фторафура являлись тошнота и рвота.

Ни один из представленных режимов химиотерапии не продемонстрировал преимуществ в эффективности и переносимости.

Литература

1. World Health Statistics 2008. Geneva, World Health Organization, 2008.
2. Conditional survival analyses across cancer sites. / Ellison LF, Bryant H, Lockwood G, Shack L. // Health Rep, 2011, Vol. 22, № 2, P. 21 – 25.
3. Superior survival with capecitabine plus docetaxel combination therapy in anthracycline-pretreated patients with advanced breast cancer: phase III trial results / J. O'Shaughnessy, D. Miles, S. Vukelia, V. Moiseyenko et al. // J. Clin. Oncol., 2002, Vol. 20, P. 2812 – 2823.
4. Stathopoulos G. P., Rigatos S. K., Pergantas N. / Phase II trial of biweekly administration of vinorelbine and gemcitabine in pretreated advanced breast cancer // J. Clin. Oncol., 2002, Vol. 20, P. 37 – 41.